HERRAMIENTA EVALUACIÓN ADHERENCIA GPC SCC

En el presente documento se describe detalladamente la herramienta de evaluación de adherencia basada en GPC ESC 2024 para el Síndrome Coronario Crónico (SCC) y adaptada al contexto institucional.

La escala de calificación es:

0: No aplica (no puntúa)
1: No cumple o cumplimiento mínimo del ítem
4: Cumplimiento adecuado del ítem
5: Cumplimiento total del ítem

Calificación 1 – No cumple / cumplimiento mínimo

Se asigna cuando **no existe registro en la historia clínica**, el registro es **incompleto**, o **no se evidencia la realización o solicitud del estudio/intervención indicada según el ítem evaluado**. También aplica cuando la información consignada es insuficiente para verificar el cumplimiento del criterio.

Calificación 4 – Cumplimiento adecuado

Se asigna cuando **existe registro en la historia clínica que evidencia el cumplimiento del criterio evaluado**, incluyendo la solicitud del estudio, intervención o valoración correspondiente; sin embargo, **la información puede ser parcial o no incluir todos los elementos recomendados por la guía**, aunque permite verificar razonablemente que la conducta fue realizada.

Calificación 5 – Cumplimiento total

Se asigna cuando **el criterio se cumple completamente y se encuentra claramente documentado en la historia clínica**, incluyendo todos los componentes recomendados por la guía de práctica clínica (registro clínico completo, solicitud o realización del estudio correspondiente, interpretación cuando aplique y coherencia con el contexto clínico del paciente).

- Ítems de evaluación

ÍTEM DE EVALUACIÓN	CRITERIO DE CALIFICACIÓN
1. Caracterización clínica	Realiza y registra en la historia clínica una valoración clínica completa, que incluya la descripción detallada de los síntomas (dolor torácico, disnea u otros equivalentes), la identificación de factores de riesgo cardiovascular y comorbilidades, así como la realización y registro del examen físico cardiovascular.
2. ECG de Reposo	Solicita electrocardiograma de 12 derivaciones en pacientes con sospecha de síndrome coronario crónico (SCC), evidenciándose en la historia clínica el registro de la solicitud correspondiente del estudio.
3. Laboratorio Básico	Solicita perfil lipídico, hemograma, creatinina (TFG), HbA1c/glucosa y función tiroidea (si está no estaba previamente registrada) en paciente con sospecha de SCC, evidenciándose en la historia clínica el registro de la solicitud correspondiente de los estudios
4. Ecocardiograma	Solicita ecocardiograma transtorácico para evaluar FEVI y motilidad segmentaria), evidenciándose en la historia clínica el registro de la solicitud correspondiente del estudio. ** Este ítem **no aplica para Medicina General**, debido a las limitaciones actuales relacionadas con la autorización por parte de las EAPB para la solicitud directa de este estudio.
5. Estimación de Probabilidad	Aplica el modelo RF-CL (edad, sexo, síntomas, factores riesgo) para categorizar la probabilidad clínica y registra dicho porcentaje en la historia clínica.
6. Reclasificación (5-15%)	Indica en pacientes con riesgo bajo (5-15%) Score de Calcio (CACS) o prueba de esfuerzo para reajustar el riesgo, evidenciándose en la historia clínica el registro de la solicitud correspondiente del estudio. ** Este ítem **no aplica para Medicina General**, debido a las limitaciones actuales relacionadas con la autorización por parte de las EAPB para la solicitud directa de este estudio.

7. Selección de Estudios Diagnósticos No invasivos según riesgo	Indica Angio-TAC para riesgo bajo/moderado o pruebas Funcionales (Eco-estrés/SPECT) para riesgo moderado/alto, evidenciándose en la historia clínica el registro de la solicitud correspondiente del estudio. ** Este ítem **no aplica para Medicina General**.
8. Indicación de ACI	Indica coronariografía invasiva para pacientes con riesgo muy alto (>85%), evidenciándose en la historia clínica el registro de la solicitud correspondiente del estudio. ** Este ítem **no aplica para Medicina General**
9. Terapia no Farmacológica	Realiza registro de las medidas no farmacológicas: estilos de vida saludable (pérdida de peso, cese de tabaquismo, realizar actividad física, cese consumo de alcohol, etc.)
10. Terapia Farmacológica: Anti-anginosa	Inicia manejo escalonado (BB o BCC). También puede indicar combinación de estos grupos farmacológico o indicación de Trimetazidina, evidenciándose en la historia clínica el registro del tratamiento
11. Terapia Farmacológica: Prevención eventos cardiovasculares	Indica o continua terapia antiagregante plaquetaria en monoterapia, preferiblemente con ácido acetilsalicílico (75–100 mg/día) o clopidogrel (75 mg/día) de forma indefinida en pacientes con enfermedad coronaria obstructiva documentada, evidenciándose en la historia clínica el registro del tratamiento.
12. Terapia Farmacológica: Prevención eventos cardiovasculares	Prescribe o intensifica tratamiento de estatinas de alta intensidad para alcanzar meta de cLDL < 55 mg/dL y reducción ≥ 50%, evidenciándose en la historia clínica el registro del tratamiento **Se debe registrar meta de LDL en historia clínica

- Definición operativa de cumplimiento de los ítems evaluados (escala 1-4-5)

Ítem 1. Caracterización clínica

1 – No cumple
No se evidencia en la historia clínica la descripción de síntomas, factores de riesgo cardiovascular ni examen físico cardiovascular.

4 – Cumple adecuadamente
Se registran algunos elementos de la valoración clínica (síntomas o factores de riesgo o examen físico), pero la información aún es incompleta.

5 – Cumple totalmente
Se documenta valoración clínica completa: descripción de síntomas (dolor torácico o equivalentes), factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades y examen físico cardiovascular.

Ítem 2. ECG de reposo

1 – No cumple
No se evidencia solicitud ni registro de electrocardiograma.

4 – Cumple adecuadamente
Se menciona el ECG, pero no se evidencia solicitud de la orden.

5 – Cumple totalmente
Se evidencia claramente en la historia clínica registro y solicitud del ECG.

Ítem 3. Laboratorio básico

1 – No cumple
No se solicitan ni se registran estudios de laboratorio recomendados.

4 – Cumple adecuadamente
Se solicitan algunos de los estudios recomendados (perfil lipídico, hemograma, creatinina/TFG, HbA1c o glucosa, función tiroidea).

5 – Cumple totalmente
Se solicitan y registran todos los estudios de laboratorio recomendados o se evidencia que ya estaban disponibles previamente.

Ítem 4. Ecocardiograma

1 – No cumple
No se evidencia solicitud de ecocardiograma.

4 – Cumple adecuadamente
Se menciona la necesidad del estudio o existe referencia indirecta, pero no evidencia solicitud del mismo.

5 – Cumple totalmente
Se evidencia registro y solicitud de ecocardiograma transtorácico para evaluar FEVI y motilidad segmentaria.

Ítem 5. Estimación de probabilidad clínica (RF-CL)

1 – No cumple
No se realiza estimación de probabilidad pretest ni se registra en la historia clínica.

4 – Cumple adecuadamente
Se realiza valoración clínica del riesgo, pero no se documenta el porcentaje o no se especifica el uso del modelo RF-CL.

5 – Cumple totalmente
Se aplica el modelo RF-CL y se registra el porcentaje de probabilidad clínica en la historia clínica.

Ítem 6. Reclasificación (5–15%)

1 – No cumple
En pacientes con riesgo bajo (5-15%) no se solicita estudio para reclasificación.

4 – Cumple adecuadamente
Se menciona la necesidad de reclasificación, pero no se evidencia solicitud clara del estudio.

5 – Cumple totalmente
Se solicita Score de Calcio (CACS) o prueba de esfuerzo y queda registrado en la historia clínica.

Ítem 7. Selección de estudios diagnósticos no invasivos

1 – No cumple
No se solicita estudio diagnóstico acorde al riesgo clínico.

4 – Cumple adecuadamente
Se solicita un estudio diagnóstico, pero no corresponde completamente al nivel de riesgo o no queda claramente documentado.

5 – Cumple totalmente
Se solicita Angio-TAC para riesgo bajo/moderado o prueba funcional (Eco-estrés/SPECT) para riesgo moderado/alto, evidenciado justificación clara en la historia clínica.

Ítem 8. Indicación de angiografía coronaria invasiva

1 – No cumple
En pacientes con riesgo muy alto no se evidencia indicación de coronariografía.

4 – Cumple adecuadamente
Se menciona la necesidad de evaluación invasiva o remisión, pero no se registra claramente la solicitud.

5 – Cumple totalmente
Se documenta la indicación o solicitud de coronariografía invasiva en pacientes con riesgo >85%.

Ítem 9. Terapia no farmacológica

1 – No cumple
No se registran recomendaciones de estilos de vida.

4 – Cumple adecuadamente
Se registran algunas recomendaciones generales de estilo de vida.

5 – Cumple totalmente
Se documentan recomendaciones completas: actividad física, control de peso, cese de tabaquismo, reducción de alcohol y otras medidas de estilo de vida saludable.

Ítem 10. Terapia farmacológica antianginosa

1 – No cumple
No se inicia tratamiento antianginoso.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe tratamiento antianginoso, pero no sigue claramente el enfoque escalonado recomendado.

5 – Cumple totalmente
Se inicia manejo escalonado con BB o BCC y se documenta adecuadamente el tratamiento o combinación farmacológica.

Ítem 11. Terapia farmacológica para prevención de eventos cardiovasculares (antiagregante)

1 – No cumple
No se prescribe terapia antiagregante en paciente con enfermedad coronaria documentada.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe antiagregante, pero el registro es incompleto o no se especifica claramente dosis.

5 – Cumple totalmente
Se prescribe y registra antiagregante (AAS o clopidogrel) con dosis adecuada.

Ítem 12. Terapia farmacológica para prevención de eventos cardiovasculares (estatinas)

1 – No cumple
No se prescribe estatina ni se documenta manejo del LDL.

4 – Cumple adecuadamente
Se prescribe estatina, pero no se evidencia intensidad del tratamiento o meta de LDL.

5 – Cumple totalmente
Se prescribe estatina de alta intensidad y se registra meta de LDL (<55 mg/dL o reducción ≥50%).